Diskussion 552

Datum: 1928-03-23
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 10
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus, byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).
Projekt: https://github.com/DigitalHistory-Lund/ToK-Preparer
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18211787
Version: 2026.10.14

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Jakob Pettersson (–, man)

Statsutskottet, som ju i allmänhet har ställt sig mycket välvilligt till Kungl. Maj:ts anslagsäskanden under femte huvudtiteln, har icke funnit sig kunna tillstyrka förslaget om bidrag till anskaffande av sg. k. läkarbilar. Detta förslag är föranlett av en riksdagsskrivelse av 1920, vari begärdes utredning, huruvida och på vad sätt åtgärder kunde vidtagas i syfte att förbättra sjuktransporterna till och från sjukhus på landsbygden, och i det uttskottsbetänkande, som låg till grund för riksdagens skrivelse, framhölls, att man avsåg en utredning av alla de särskilda spörsmål, som kunde inbegripas i denna fråga, sålunda inte endast frågan om transport av sjuka. Röda korsets överstyrelse, som haft Kungl. Maj:ts uppdrag att utreda frågan, har till förbättringen av sjuktransportförhållandena på landsbygden framlagt en mycket omfattande plan, som upptager först och främst frågan om förbättring av Järnvägarnas sjuktransportmedel, vidare sjuktransporter med aeroplan, anskaffning av skidbårar och slädfordon för sjuka och slutligen anskaffande av olika slag av bilar för transport av sjuka.

Utav dessa förslag har jag ansett endast anslagen till skidbårar samt till uppmuntrande av anskaffandet av s. k. läkarbilar kunna förordas. Statsutskottet har åter stannat vid att endast tillstyrka anslaget till skidbårar. Det av statsutskottet avstyrkta förslaget om anslag till läkarbilar går i huvudsak ut på att bidrag å minst 1,000 och högst 2.500 kronor skulle lämnas för anskaffande, drift och underhåll av bilar, avsedda för transport av sjuka och så inrättade, att de sjuka kunna transporteras i liggande ställning, varjämte bilarna ock skola vara försedda med bårar. Bidrag skulle lämnas till tjänsteläkare, landsting, landskommun, förbund av dylika kommuner eller till sjukvårdsförening, som ville engagera sig för saken. Som villkor för anslags åtnjutande skulle uppställas, att vederbörande ägare av bilen förbunde sig att under två års tid hålla densamma tillgänglig för transport av sjuka till och från sjukhus, för läkares resor i tjänsten och slutligen också för distriktssköterskas och distriktsbarnmorskas resor i tjänsten, då särskild skyndsamhet vore av nöden. Dessutom skulle av anslaget för detta ändamål enligt förslaget utgå särskild ersättning till automobilens ägare för transport av sjuka och för transport av **barnmorska³** och **sköterska³** samt slutligen också för läkarens resor, för såvitt icke läkaren själv vore ägare till automobilen. Om **barnmorska³** och **sköterska³** finge göra sällskap med läkaren, skulle särskild ersättning för resan icke utgå.

Härtill säger nu utskottet, att förslaget är förenat med bristfälligheter och särskilt, att sättet för utnyttjandet av anordningen kan komma att visa sig otillfredsställande. Jag antar, att utskottet härmed syftar på att man inte har kunnat träffa en sådan anordning, att det kan förekommas, att på samma gång uppstår behov av samma bil för olika ändamål. Den kan behövas samtidigt för en resa åt ena hållet och en resa åt andra hållet. Det är ju möjligt. att svårigheter i anmärkta hänseendet skulle kunna uppstå. Men jag ber på samma gång att få framhålla, att det förslag, som här framlagts, endast är en tillämpning, en vidare utvidgning av det system för anskaffande och begagnande av bilar, som redan tillämpas i rikets ödemarksområden och som där visat sig ganska tillfredsställande. Vidare vill jag framhålla, att det i alla fall här gäller en försöksanordning, och det vore ju, om nu anslaget beviljades, skäl i att under denna första tid pröva sig fram och undersöka vilka svårigheter och olägenheter, som kunna vara förenade med anordningen, så att man sedan kunde bättra på systemet. I varje fall synes det mig vara ganska klart, att även om den föreslagna anordningen inte skulle kunna riktigt fylla måttet och bli så tillfredsställande, som man skulle önska, vore det väl i alla fall betydligt bättre att på åtskilliga håll anskaffades läkarbilar, försedda med anordningar för att transportera sjuka i liggande ställning, än att

icke ha några sådana automobiler alls eller i otillräckligt antal. Jag vill även framhålla, att av alla de förslag, som här äro framställda av Röda korset, icke något vunnit så allmän anslutning av de hörda myndigheterna, länsstyrelser och landsting, som detta om bidrag till egna läkarbilar.

Till sist hoppas jag, att kammaren inte tar illa upp, om Jag säger, att detta är en fråga av ej ringa betydelse. Det gäller att göra åtminstone en början till att för stora områden av vårt land minska de lidanden, som de sjuka nu ofta måste utstå till följd av olämpliga transportförhållanden, och det gäller också att åstadkomma skyndsamhet i dessa transporter, en skyndsamhet, som i många fall kan vara villkoret för att ett människoliv skall kunna räddas. Det synes mig, att dessa synpunkter äro så pass viktiga, att man trots de bristfälligheter, som kunna vara förenade med förslaget, skulle kunna godkänna detsamma.

Jag tillåter mig att uttala den förhoppningen, att den reservation, som här är framställd och som går ut på att sänka minimum av anslag för varje bil till 500 kronor, måtte vinna kammarens bifall.

2. Janne Walles (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Efter departementschefens anförande skall Jag endast be att få yttra ett par ord. Som departementschefen erinrade, föranstaltades ju på grund av ett riksdagsbeslut en utredning, vari Röda korset deltog. Det av Röda korset framlagda förslaget, som var mycket omfattande, har varit på remiss bl. a. till länsstyrelserna och provinsialläkarna. Det har fått ett mycket gott vitsord såsom varande synnerligen praktiskt och lämpligt. Emellertid har departementschefen, såsom anförts, ansett sig inte kunna framföra förslaget i sin helhet utan inskränkt sig till denna detalj, nämligen angående bidrag till läkarbilar. Medicinalstyrelsen har

för sin del mycket varmt tillstyrkt och förordat förslaget om bidrag till läkarbilar och anför, att »erfarenheten från ödemarksområdena om statsbidrag till läkarautomobiler hade varit god. Med ledning av de för nämnda områden gällande bestämmelserna borde alltså statsbidrag kunna få utdelas även i övriga delar av riket.> Länsstyrelserna ha i allmänhet tillstyrkt förslaget. Länsstyrelsen i Malmöhus län framhåller, att de sjuktransportmedel, på vilkas åvägabringande och utveckling strävandena inom länet särskilt borde inriktas, vore — jämte ambulansbilar — egna läkarbilar. Till dessas anskaffande borde staten bidraga med en tredjedel av inköpspriset. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har uttalat, att det vore givet, att dylika bilar skulle bliva till stor nytta för sjukvården å landsbygden, oavsett om ambulansbilar i någon större utsträckning komme till användning. Slutligen har länsstyrelsen i Örebro län åberopat yttrande från förste provinsialläkaren i länet, i vilket anförts, att erfarenheten från ett provinsialläkardistrikt inom länet, som anskaffat och ställt till läkarens förfogande en automobil att användas till sjukresor inom distriktet, styrkt uppfattningen om lämpligheten av förevarande förslag. |

Vi se sålunda, att från myndigheter, som böra känna till förhållandena på området, har förslaget vunnit synnerligen stort erkännande. Jag kan därför icke finna annat än. att utskottet mycket snävt har behandlat detta förslag, och jag kan för min del inte anse det vara korrekt, då ett förslag är så pass väl motiverat som detta och avser att bistå sjukvården i vårt land, att man avfärdar det på så kortfattat sätt som skett. Här har endast yrkats bifall till 50 st. skidbårar med ett belopp på 3,000 kronor, och det av medicinalstyrelsen äskade beloppet på 70,000 kronor, som av departementschefen nedsatts till 50.000 kronor, har utskottet avslagit.

Då jag för min del är mycket livligt övertygad om att åtgärden skulle komma till gagn för sjukvården i vårt land, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

3. Wilhelm Björck (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Det är ju, som herr statsrådet och chefen för socialdepartementet nyss yttrade, inte någon stor fråga, som det här gäller, men då man går att ur statsutskottssynpunkt bedöma framställningar, som föreläggas riksdagen, vill man gärna pröva dem ur praktiska synpunkter, och vid en sådan prövning har det förslag, vilket socialministern här ömmar för, inte hållit måttet. Det bör understrykas — det framgick ju nyss av herr statsrådets redogörelse — att den här omstridda punkten är ett led i ett ganska stort tilltaget kristidsförslag. Det har också fått sitt uttryck i det förhållandet, att departementschefen själv har nödgats beskära det högst väsentligt. Av denna jätteplan för bispringande vid transporter av sjuka i olika delar av landet återstå således efter regeringens granskning inte mer än två punkter, nämligen den om läkarbilar och den om skidbårar. Statsutskottet har ytterligare överarbetat förslaget med det resultatet, att kvar står endast förslaget om statsbidrag för anskaffande av skidbårar. Jag tror, att själva överarbetningen på olika håll har ägt rum från samma utgångspunkter. Man har sett till vad som varit finansiellt möjligt och vad som varit praktiskt realiserbart. Ätskilligt i denna stora plan har fått vika inför socialministerns granskning, därför att statsfinanserna inte medgåvo det, och beträffande just nu ifrågavarande anslag till bidrag åt läkarbilar har, som av handlingarna framgår, redan socialministern sett sig nödsakad att gå in för en beskärning av

den plan, som ursprungligen var utarbetad.

När man i utskottet gick att granska denna beskurna plan ur praktisk synpunkt, snubblade man först på uttrycket »tjänsteläkare». Den saken var inte utredd. Vad är tjänsteläkare? Vilka läkare skola komma i åtnjutande av denna förmån? De förfrågningar, som gjordes hos den ansvariga myndigheten, kunde inte bringa någon klarhet om i vilken utsträckning tjänsteläkare äro avsedda att kunna ifrågakomma för understöd till sådana bilar. Man måste dock säga, att det är en ganska primär fordran, när man skall bevilja ett anslag, som skall utgå till tjänsteläkare, att man vet vilka som faktiskt äro berättigade att få anslag.

Det var emellertid inte den svåraste stötestenen. Så kom man in på villkoren för användande av detta anslag. Därvidlag har herr statsrådet mycket starkt understrukit, att det skulle vara för transport av sjuka, men läser man framställningen, blir man övertygad om att det bleve mycket få sjuka, som skulle bli transporterade i dessa bilar. De äro naturligtvis i första rummet avsedda för tjänsteläkarens resor. Naturligtvis kan tjänsteläkare i vissa fall vid ett sjukbesök taga med en sjuk till någon sjukstuga eller sjukvårdsanstalt. Men det blir säkert ganska sällan. Men så ha vi tredje punkten, på vilken förslaget egentligen stupade i utskottet. Bilen skall användas för distriktssköterskas och distriktsbarnmorskas resor, som för fullgörande av deras tjänst böra skyndsamt utföras. Den som har någon praktisk erfarenhet vet, att en distriktbarnmorskas resor i allmänhet äro av den naturen, att de böra skyndsamt utföras, och följaktligen skulle ju distriktsbarnmorskan alltid kunna göra anspråk på att få skjuts i bilen. Det är inte något ont i det, men det finns ett mycket viktigt men. Då man inte förutsatt, att det skall vara chaufför till dessa bilar, kommer man i det läget, att läkaren skall stå tillgänglig på rekvisition av distriktssköterskan eller distriktsbarnmorskan för att köra dem till de platser, där deras närvaro är av behovet påkallad. Det är framförallt denna omständighet, som gjort, att statsutskottet har ställt sig mycket betänksam mot detta anslagskrav. Man måste nämligen säga sig, att antingen är

distriktssköterskan eller distriktsbarnmorskan en mycket diskret person — gent emot läkare äro ju **sköterskor³** och barnmorskor i regel ganska väl disciplinerade — och kommer inte att ställa några krav på att få åka i den där bilen, eller också är **hon²** av det mera påstridiga slaget, och då tager **hon²** bort läkarens tid för de sjuka och anlitar honom i stället såsom chaufför.

Det är sålunda rent praktiska skäl, som föranlett utskottet att avböja att ställa pengar till förfogande för understöd för anskaffande och användning av läkarbilar på dessa villkor. Annorlunda hade läget givetvis varit, om det hade uppställts som uttryckligt villkor, att det skulle finnas chaufförer till dessa bilar och om anslagsbeloppet hade utmätts därefter. Men med de bidragsbelopp på mellan 500 och 2.500 kronor, som reservanterna här förordat, inser var man, att det bidragsbeloppet medger icke hållande av en körkunnig man, som sköter bilen.

Det bör också nämnas — det kunna herrarna själva räkna ut — att något större antal läkarbilar kan det inte bli tal om med ett belopp på 50,000 kronor, som skall fördelas i bidrag på mellan 500 och 2,500 kronor för varje bil. Det har tydligen inte heller varit avsett. Om nu detta system fungerar någorlunda tillfredsställande inom ödemarksområdena, vill jag fästa uppmärksamheten på att det är dock en väsentligen annan sak att överflytta detsamma till landet i dess helhet, till de tätare befolkade trakterna. Vad förslå då dessa 30 bilar, som departementschefen räknat med? |

Hade det varit så, att man haft några som helst utsikter för att genom beviljande av dessa 50,000 kronor kunna väsentligt minska lidandet för de sjuka och åstadkomma, att man fick lämpliga transportmedel, skulle jag för min del inte haft det ringaste emot detta anslag. När man emellertid har en bestämd förkänsla av att det i praktiken inte kommer att spela någon roll och att förslaget är tillrättalagt — förlåt, att jag säger det — med något opraktiska händer, skulle jag med väsentligt större tillfredsställelse ha hälsat, om man 1 stället fått ett kraftigare stöd för de ambulansbilar, som man ju över allt i landet genom landstingens försorg har skaffat sig. Jag tror, att dessa ambulansbilar i de tätare befolkade delarna av landet äro det normala medlet för att transportera sjuka från hemmet till de centrala sjukvårdsanstalterna.

Jag har med dessa ord, herr talman, velat klargöra de synpunkter, som ha lett statsutskottets majoritet, då den bestämt har velat avböja medverkan till det projekt, som från Kungl. Maj:ts sida här har förelagts riksdagen, och jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

4. Herman Kvarnzelius (Folkpartiet, man)

Herr talman! Jag har icke deltagit inom statsutskottet vid handläggningen av det här ärendet, och jag har därför begärt ordet endast för att deklarera min ståndpunkt. Jag vill då säga, att jag ansluter mig utan någon som helst tvekan till Kungl. Maj:ts förslag i denna del och att jag följaktligen yrkar bifall till den vid denna punkt fogade reservationen.

Om jag fattade herr Björck rätt, sade han, att förslaget delvis var en kvarleva av vissa kristidsåtgärder. Ja, Kungl. Maj:ts här föreliggande förslag om sjukvårdstransporter avser ju företrädesvis att komma till användning i de nordliga delarna av landet, där det är mycket långt till läkare och ännu mycket längre till sjukhus. Om en läkare har en bil så anordnad, att han, om han blir kallad till en plats på sjukbesök och finner det nödvändigt, att den sjuke omedelbart kommer till sjukhus, kan taga den sjuke med sig, vilket värde ligger det då inte i att ha bilen så anordnad, att detta kan ske! Han kan då medtaga den sjuke på en och samma gång och transportera honom till sjukhuset. Därpå kan den sjukes liv bero. Det är sålunda en i hög grad

humanitär åtgärd, det här är fråga om, och alltid ordnar det sig med både chaufförer och annat, bara man har den goda viljan. Jag ber att få yrka bifall till reservationen.

5. Kerstin Hesselgren (Folkpartiet, woman)

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av herr Björcks yttrande, att en väsentlig orsak

till att man inte skulle kunna använda sig av sådana här läkarbilar vore den, att vederbörande läkare eventuellt skulle få lov att tjänstgöra som chaufför för barnmorskan eller **sköterskan**[3]. Jag vill då säga, att jag känner många både **sköterskor**[3] och barnmorskor, som själva köra sina bilar. Det blir mer och mer vanligt, att distriktssköterskor, som ha långa vägar att resa, lära sig köra bil, så att de lika väl som läkarna kunna använda bil i tjänsten. Att den här ifrågasatta typen av bilar är av mycket stor betydelse, tror jag, att alla, som varit i tillfälle att se dem, äro medvetna om. Att de äro lättare att använda än de egentliga ambulansbilarna, tror jag också, att man måste säga, och detta gäller i synnerhet i de nordliga trakterna av vårt land. Jag anser, att det vore oerhört synd, om man inte finge hjälp att gå fram på denna väg, som man redan på enskilt initiativ på många platser slagit in på, att ordna dessa transporter, och jag ber för den skull, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

6. Ewert Jonsson (–, man)

Herr talman! Herr socialministern sade i sitt anförande, att denna fråga icke var stor, och herr Björck tog fasta på detta yttrande. Jag vill för min del tvärtom säga, att denna fråga är en mycket stor fråga för de människor, som det här närmast gäller, och särskilt för befolkningen i våra lappmarker. Jag skulle kunna tala om upprörande fall, då vederbörande fått lida både nöd och död därför att icke utvägar stått till buds i sådan riktning, com man nu här föreslagit och som reservanterna upptagit i sin hemställan. Jag skall därför be, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

7. Wilhelm Björck (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Med anledning av herr Kvarnzelius” anförande vill jag fästa uppmärksamheten på, att dessa anordningar alls icke äro avsedda att tillämpas endast i de nordliga delarna av landet. De äro avsedda för tjänsteläkare av olika kategorier i landet i dess helhet, ehuru envar kan vara övertygad om att det stora flertalet av dessa läkare redan har bilar, i vilka de också kunna transportera de sjuka, när de äro i behov av skyndsam transport. Ätminstone har jag aldrig mött någon läkare med en så byråkratisk syn på sina uppgifter, att han skulle ha vägrat att medtaga den sjuke, om nöden påfordrat det, i sin egen bil.

Frågan gäller här egentligen, att läkare för att få bidrag till bilens drift skall vara skyldig att alltid stå distriktssköterska eller distriktsbarnmorska till tjänst, när helst **hon**[2] påkallar det. Det är detta villkor, som efter min mening kommer att stjälpa hela denna sak i praktiken. Ett sådant villkor kan, försåvitt jag förstår, ingen läkare godtaga, om han nämligen även vill fullgöra, vad som föreskrives och kräves för att bidrag skall utgå.

Jag kan sålunda icke, när det gäller att bedöma en anslagsfråga sådan som denna, dela den glada optimism, som kom till synes från statsutskottets ärade ordförandes sida, då han försäkrade, att beviljas bara pengarna, så klarar sig nog resten av sig själv. Jag tror, att det är nödvändigt att från början äga full visshet om den anordning, som vi här ha att pröva, är välbetänkt eller icke. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.

8. Jakob Pettersson (–, man)

Herr talman! Herr Björck har å utskottets vägnar talat emot det ifrågasatta anslaget, såvitt jag förstod honom rätt, huvudsakligen av två skäl. Det ena var, att av förslaget icke tydligt skulle framgå, vad som menas med tjänsteläkare, och det andra, att det icke tilllika är begärt anslag till avlönande av chaufför samt att bidraget därför skulle bli för litet för att kunna spela någon roll.

Vad först beträffar frågan, vilka tjänsteläkare som här skulle avses, framgår av hela motiveringen till förslaget, att det är fråga om sjuktransporter på landsbygden. Vid prövning av eventuellt inkommande ansökningar om bidrag skulle det naturligtvis bli nödvändigt att väga behovet och övriga omständigheter, till vilka hänsyn böra tagas, emot varandra. Bidragen skulle då komma företrädesvis de landskommuner eller landsting till del, där behovet är störst. Vid sådant förhållande borde det icke vara så synnerligen svårt att i tillämpningsväg bestämma, vilka grupper av tjänsteläkare det här kan bli fråga om. Såvitt jag kan förstå bleve det provinsialläkare, extra provinsialläkare och distriktsläkare. — Att stadsläkare skulle kunna komma i fråga, kan jag knappast tänka mig.

Vad vidare beträffar frågan om chaufförer för dessa bilar, vill jag påpeka, att denna fråga verkligen i någon mån upptagits i motiveringen. Det står där, att om vederbörande utfäster sig att hålla person för bilens förande, skall bidraget bestämmas högre än i motsatt fall. De som äro i tillfälle att hålla chaufförer skulle sålunda ha utsikter att få ett större bidrag för ändamålet.

Herr Björck var rädd för att denna anordning skulle komma att medföra ohemula anspråk från distriktsbarnmorskornas och distriktssköterskornas sida, så att läkarna skulle kunna få tjänstgöra som deras chaufförer. Jag tror. att detta är att alltför lågt värdesätta omdömesförmågan hos våra barnmorskor och **sköterskor**[3]. Jag tänker mig, att bilarnas användning för deras räkning huvudsakligen skulle komma i fråga, när läkaren hade en resa att göra, vid vilken han skulle kunna taga barnmorskan eller **sköterskan**[3] med sig 1 bilen, för den händelse att deras färd ginge något så när åt samma håll som hans egen. För övrigt är det ju icke uteslutet, att det på annat sätt skulle kunna tillhandahållas en verklig chaufför för framförande av ifrågavarande bilar.

Den omständigheten slutligen, att det nu icke skulle bli fråga om något större antal läkarbilar, synes mig icke böra avskräcka från ett bifall till förslaget. Ty som redan förut har framhållits, är det endast fråga om ett försök, och skulle det lyckas, kan det för framtiden finnas alla utsikter för att söka anskaffa ett större antal.

9. Eric Hallin (–, man)

Herr talman! Jag ber endast få säga, att det förefaller mig, som om herr Björcks argumentering mest påminde om de obotfärdigas förhinder. Herr statsrådet och chefen för socialdepartementet har ju också punkt för punkt bemött de små formella invändningar, som herr Björck hade att göra mot det föreliggande förslaget, vilket ju har framkommit för att realisera blott en ringa del av vad riksdagen på sin tid begärt beträffande ordnandet av

transporten av de sjuka. Herr Björck sade bl. a., att det var föreslaget ett löjligt lågt minimum — latituden ligger nämligen mellan 500 och 2,500 kronor. Vad kan man, sade han, begära att få för 500 kronor? Härtill vill jag erinra, att det alls icke behöver tillämpas något minimum. Att reservanterna här ha satt 500 kronor i stället för föreslagna 1,000 kronor var av det skälet, att man mycket väl kan tänka sig, att tillfällen kunna förekomma, då man icke behövde gå så långt som till 1,000 kronor, och för att göra det möjligt att överhuvud taget utanordna ett mindre anslag har

man satt minimibeloppet till 500 kronor. Man kan lika väl taga bort minimum och bestämma endast ett maximum, vilket ju är det väsentliga.

Jag ber, herr talman, att på det varmaste få rekommendera reservationen, till vilken jag yrkar bifall.

10. Wilhelm Björck (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Endast ett par ord! Jag skall be att få tacka för att här nu omsider blivit klarlagt, vad uttrycket »tjänsteläkare» egentligen innebär. Jag får hoppas, att den lämnade uppräkningen av de kategorier läkare, vilka här kunna komma i fråga, är fullständig.

Vidare har herr statsrådet och chefen för socialdepartementet anfört, att det i motiveringen talas om att chaufförer skola kunna anlitas. Det är alldeles riktigt, och det visste jag mycket väl. Men med 2,500 kronor i bidrag till bilens hela drift — det är ju maximibidraget — är jag övertygad om, att ingen bilägare vill förbinda sig att tillhandahålla en chaufför när som helst året om. Det är på denna punkt, som jag menar, att förslaget är opraktiskt. Visserligen uttalade herr statsrådet, att det skulle var så synnerligen lätt att kombinera barnmorskornas och läkarnas intressen, men jag vill fästa uppmärksamheten på, att det också står i motiveringen, att ett villkor för bidrags beviljande är, att bilarna skola kunna anlitas för »distriktssköterskas och distriktsbarnmorskas resor, som för fullgörande av deras tjänst böra skyndsamt utföras». Här kan det, efter mitt sätt att se, uppstå fara för ständiga konflikter och gnissel. Ty kan man garantera att, som herr statsrådet sade, **sköterskornas**[3] och barnmorskornas och läkarnas väg alltid är densamma? Kan det icke lika gärna låta sig tänkas, att de kallas åt olika håll? Vem skall då ha företräde?

Jag menar, att själva utformningen av detta förslag är sådant, att den kritik, som rests däremot, alls icke kan med berättigande karakteriseras som ett utslag av de obotfärdigas förhinder, som herr Hallin sade, utan det är kravet på att ha ett klart och pregnant formulerat förslag, innan man går att vidtaga några åtgärder, som har bestämt utskottet, när man icke velat tillmötesgå Kungl. Maj:ts framställning i denna del.